

Analyse d'activité du cabinet médical

Période étudiée : janvier 2022 – mai 2026

1. Contexte et objectifs

Analyse des données d'activité du cabinet afin d'identifier les tendances d'activité et de recettes, comprendre l'évolution de la patientèle, estimer la charge de travail et proposer des pistes d'optimisation.

2. Méthodologie

- Consolidation des exports Excel fournis.
- Nettoyage et harmonisation des données.
- Anonymisation des identifiants patients.
- Agrégation temporelle des indicateurs.
- Estimation indirecte de la charge de travail à partir des horaires communiqués.

3. Synthèse annuelle

Année	Patients estimés	Consultations	Visites	Recettes (€)
2022	546	2344	21	62072.50
2023	525	2386	6	61779.70
2024	546	2347	7	63002.61
2025	487	2126	5	64514.50
2026*	312	689	4	20649.00

* Données partielles au 16 mai 2026.

4. Analyse comparative

Dynamique de la patientèle (estimation)

Transition	Nouveaux	Non revus	Communs
2022→2023	158	179	367
2023→2024	181	160	365
2024→2025	131	190	356
2025→2026*	41	216	271

Évolution économique

Année	Tarif moyen / consultation (€)
2022	26.48

2023	25.89
2024	26.84
2025	30.35
2026*	29.97

5. Charge de travail estimée

Année	Consult./jour	Durée implicite (min)
2022	9.53	50.4
2023	9.36	51.3
2024	8.76	54.8
2025	8.44	56.9
2026*	7.83	61.3

Référence indicative : standards historiques DREES autour de 15 à 20 minutes par consultation de médecine générale, à interpréter selon le mode d'exercice.

6. Recommandations opérationnelles

- Explorer une optimisation progressive du temps médical sans dégrader la qualité d'écoute.
- Réinvestir le temps libéré dans l'administratif, la structuration des données et la gestion des imprévus.
- Mettre en place un suivi régulier des indicateurs clés.

7. Conclusion

Le cabinet présente une activité stable, une patientèle fidèle avec renouvellement, et une progression du revenu moyen par consultation. Une optimisation organisationnelle douce pourrait améliorer le confort d'exercice sans dégrader la qualité du suivi.